

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド31枚) 全84問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

11.生殖器part2	31枚	84問
-------------	-----	-----

11 生殖器part2

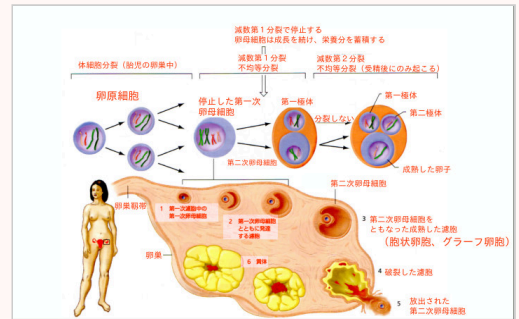
出典:生殖器 part2.pdf(スライド31枚) 全84問

卵子形成(卵の成熟過程)

- ヒトの卵子形成過程は、胎児期に卵巢中の ①
 1 と呼ばれる ② の生殖系列細胞が、③ によ
 ★★ って急速に数を増すことから始まる。

- らんげんさいぼう
 ① 卵原細胞
 ② 2倍体
 ゆうしぶんれつ
 ③ 有糸分裂

まとめ:卵原細胞は2倍体で、有糸分裂で急速に数を増す(スライドでは「有糸分裂」が太字)。図の左から1つめと2つめ(「体細胞分裂(胎児の卵巢中)」)の部分。スライド27の題は「ヒトの卵子形成は減数第1分裂前期で停止する」(次の問題)。



スライド27の図

- No.1の①の細胞は次第に減数分裂を行うが、
 2 ① の途中(前期)の、② が対合している段
 ★★ 階で分裂が停止し、③ となる。

- ① 減数第1分裂
 そうどうせんしよくたい
 ② 相同染色体
 だいいちじらんばさいぼう
 ③ 第一次卵母細胞

まとめ:減数第1分裂の途中(前期)で停止する(スライドでは「第1分裂の途中で停止」が太字)。相同染色体が対合している段階で止まっていることは、スライド29に書かれている。No.1の図の左から3つめ(「停止した第一次卵母細胞」)を確認しよう。

- No.2の③が1層の細胞に取り囲まれたものを
 3 ① という。出生までにNo.1の①の細胞は
 ★★ ② し、全ての配偶子は ③ という形で、
 ① 内に用意される。

- いちじらんぼう
 ① 一次卵胞
 ② 消滅
 だいいちじらんばさいぼう
 ③ 第一次卵母細胞

まとめ:出生までに卵原細胞は消滅し、全ての配偶子は第一次卵母細胞という形で、一次卵胞内に用意される(スライドでは太字。「全ての配偶子は第一次卵母細胞」は青字・下線)。

□□□ 思春期になると、 ① から ② (③) が
4 分泌され、No.3の③の細胞は ④ に成熟してい
★ く。

- ① かすいたいぜんよう 下垂体前葉
② らんぼう 卵胞刺激ホルモン
③ FSH
④ 1ヶ月毎

No.1の図の左から4つめ(減数第1分裂・不均等分裂)の部分。FSHは、月経周期の増殖期にも出てくる(No.33)。

□□□ 第1減数分裂では、細胞は ① に分裂し、1個の
5 ② と1個の小さな ③ を作る。 ③ は
★★ ④ 。

- ① 不均等
だいにじらんぼさいぼう
② 第二次卵母細胞
だいいちきょくたい
③ 第一極体
④ それ以上分裂しない

まとめ: 不均等に分裂する(スライドでは太字)→1個の第二次卵母細胞と1個の小さな第一極体ができる。No.1の図では、「第一極体」の横に「分裂しない」と書かれている。図の上には「卵母細胞は成長を続け、栄養分を蓄積する」とある。

□□□ No.5の②の細胞を含む卵胞は、中央に洞ができて
6 ① を貯留した ② (③) となる。
★★

- ① らんぼうえき 卵胞液
ほうじょうらんぼう
② 胞状卵胞
③ グラーフ卵胞

No.1の図の下で、「第二次卵母細胞をともなった成熟した濾胞(胞状卵胞、グラーフ卵胞)」を確認しよう(図では卵胞が「濾胞」と書かれている)。

□□□ ① の ② に刺激されて、No.5の②の細胞
7 の排卵が起こる。 ① は排卵後は卵胞に働き、
★ ③ を形成させる。

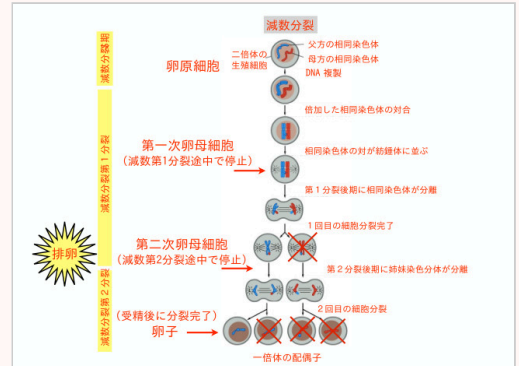
- ① 黄体形成ホルモン(LH)
② 爆発的分泌
おうたい
③ 黄体

まとめ: 黄体形成ホルモン(LH)の爆発的分泌に刺激されて排卵が起こる(スライドでは太字・下線)。この急上昇はLHサージと呼ばれる(No.24)。No.1の図の下で、「破裂した濾胞」「放出された第二次卵母細胞」「黄体」を確認しよう。

- 排卵されたNo.5の②の細胞は、①の途中まで
8 進んでいる。②と①を完了して、1倍体の
★★★ 成熟した③と1個の④を作る。

- ① 減数第2分裂
② 精子と出会う
③ 卵子
だいにくよくたい
④ 第二極体

まとめ: 排卵される第二次卵母細胞は、減数第2分裂の途中で停止している(途中まで進んでいる)。精子と出会うこと(受精)で第2分裂を完了する(スライドでは太字・下線)→1倍体の成熟した卵子と1個の第二極体。図で、「排卵」の位置と「(受精後に分裂完了)」を確認しよう。



スライド28の図

- 1個の① (2倍体)は、1回の減数分裂で、
9 ②の配偶子(1倍体)しか作らない。
★

- らんげんさいぼう
① 卵原細胞
② たった1個

まとめ: 1個の卵原細胞は、1回の減数分裂で、たった1個の卵子(配偶子)を作る(スライドでは太字・下線)。No.8の図で、2回の細胞分裂のたびに×がつき、最後に残る卵子は1個だけであることを確認しよう。

- 女性の排卵は①に始まり、②で終わる。
10 排卵が終わることを③という。
★

- ① 思春期
② 50歳前後
へいけい
③ 閉経

まとめ: 思春期に始まり、50歳前後で終わる(スライドでは太字)。男性の精子形成は、思春期に始まり一生継続する。

- 排卵が始まってから終わるまでの間に、出生時に用意された①の卵母細胞のうち、女性が生涯に放出するのは、およそ② (③)だけである。

- ① 30万個
② 480個
③ 0.16%

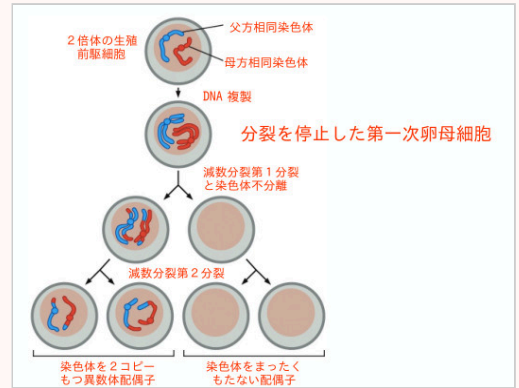
まとめ: 出生時に用意された30万個の卵母細胞のうち、女性は生涯およそ480個しか放出しない(スライドでは太字・下線)。※数値は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

染色体不分離とダウン症候群

- 減数分裂の際に相同染色体が誤った動きをしてしま
12 い、減数第1分裂で2つの別々の細胞に分離しなけれ
★ ばいけないところ、片方の細胞にのみ配分されてしま
う現象を ① という。

せんしよくたいふぶんり
① 染色体不分離

図の上から3段目(「減数分裂第1分裂と**染色体不分離**」)
で、片方の細胞にだけ染色体が配分されるようすを確認し
よう。



スライド29の図

- No.12の①の結果、特定の染色体を ① 配偶子
13 や、② を持つ配偶子ができる。このような配偶
★★ 子を ③ という。

- ① 持たない
② 余分な染色体
いすうたいはいくうし
③ 異数体配偶子

減数第1分裂で**特定の染色体を持たない細胞と余分な染
色体を持つ細胞**ができ、これらが第2分裂に入ると、それぞ
れ一倍体細胞になる。このような配偶子は受精しても大部
分は死んでしまうが、なかには生き延びるものもある。
No.12の図の一番下(「**染色体を2コピーもつ異数体配偶
子**」「**染色体をまったくもたない配偶子**」)を確認しよう。

- 高齢の女性から排卵される卵母細胞では、①
14 にわたって ② の対合が行われており、再開され
★★★ た ③ でNo.12の①が起こりやすくなって、
No.13の③を生じると考えられる。

- ① 長期間
そうどうせんしよくたい
② 相同染色体
③ 第1分裂

まとめ:**長期間にわたって相同染色体の対合が行われてお
り、再開された第1分裂で染色体不分離が起こりやすくな
るから**(スライドでは太字)。第一次卵母細胞は、出生前か
ら**減数第1分裂の途中**で止まっている(No.2)。※スライド
29の本文には「排卵後に再開された」とあるが、スライド
27・28では、排卵されるのは**第1分裂を終えた第二次卵母
細胞**である。

□□□ No.12の①が ① 番目の染色体で起き、卵子の
 15 ② 本の染色体と精子の ③ 本の染色体が
 ★★ 合わさると、その染色体を ④ 本持った ⑤
 の子どもが生まれる。このように、ある染色体が1本多
 い状態を ⑥ という。

- ① 21
 ② 2
 ③ 1
 ④ 3
 ⑤ ダウン症候群
 ⑥ トリソミー

まとめ:21番目の染色体で不分離が起き、卵子の2本の染
 色体と精子の1本の染色体が合わさる→21番の染色体を
 3本持つ(スライドでは青字・太字)。そのためダウン症候群
 は「トリソミー21」とも呼ばれる。この染色体上の遺伝子の
 量が多くなり、遺伝子から指令されるタンパク質の量が過
 剰となって、胚発生に何らかの支障を来す。図の右下(「ダ
 ウン症候群の男子」)で、21番の染色体が3本あることを確
 認しよう。



スライド30の写真と図

□□□ No.15の⑤の特徴は、① などの特徴的顔貌、
 16 ②、様々な③である。また、④の年齢
 ★★ が高い⑤になればなるほど、発症頻度が増加
 する。

- ① つり上がった小さな目
 ② 精神発達遅延
 ないぞうきけい
 ③ 内臓奇形
 ④ 母親
 ⑤ 高齢出産

まとめ:つり上がった小さな目などの特徴的顔貌・精神発
 達遅延・様々な内臓奇形。母親の年齢が高い高齢出産に
 になればなるほど増加する(スライドでは太字・下線)。表(母
 親の年齢別)では、15～29歳で1:1500、45歳以上で1:
 50。

15～29 歳	30 ～34 歳	35～39 歳	40～44 歳	45 歳以上
1 : 1500	1 : 800	1 : 270	1 : 100	1 : 50

スライド31の表

□□□ 配偶子に起こる染色体分離の誤りの頻度は驚くほど
 17 高く、特に精子よりも ① の形成段階で顕著であ
 ★★ る。① のもととなる卵母細胞では、減数分裂の
 重要 ② でNo.12の①が起きていると言われている。

- ① 卵子
 ② 約10%

まとめ:減数分裂の約10%で染色体不分離が起き(スライ
 ドでは赤字・太字・下線)、異常な染色体の数を持つ卵がで
 きていると言われている。

- ダウン症の診断方法のうち、胎児の首元のむくみを
 18 見るのは ① (②)、ホルモン・蛋白質を調
 ★★★ べるのは ③ (④)である。

- ① 超音波検査
 ② 10～15w
ぼたいけっせい
 ③ 母体血清マーカー
 ④ 15～21w

()内は検査を行う時期(w=妊娠週数)。※スライドには「人工中絶は妊娠22w未満まで(妊娠12w以降は陣痛誘発を行い死産届けが必要)」とも書かれている。

- 精度は高いが、流産の危険性があるダウン症の診断
 19 方法には、① (②)と ③ (④)
 ★★★ がある。

- ようすいけんさ
 ① 羊水検査
 ② 15～18w
じゅうもうけんさ
 ③ 絨毛検査
 ④ 9～14w

スライドのノートでも、**絨毛検査**について「精度は高いが、流産のリスクが高い」と書かれている。

- 妊婦の血漿中にたどよう胎児のDNA断片を、遺伝子
 20 を高速で解析できる次世代シーケンサーで網羅的に
 ★★ 調べ、DNA断片の量的な変化を評価して染色体の
 数的異常を診断する方法を ① (②)とい
 う。

- しんしゅっせいぜんしんだん
 ① 新生出生前診断
 ② 10～18w

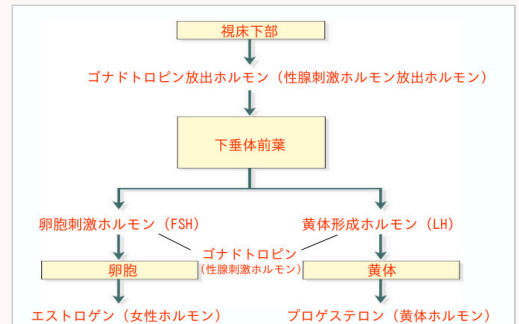
胎児および母親由来のDNA断片がどの染色体のものかを確認し、量的な変化を評価する。スライド32では、5つの診断方法のうち**新生出生前診断**だけが赤字。

女性の性ホルモン(生殖器part1の補足)

- 卵胞の成熟は、① から放出される ② (③)
 21 と、その刺激によって下垂体前葉から放出
 ★★ される2種類のホルモンによって調節されている。

- ししょうかぶ
 ① 視床下部
 ② ギナドトロピン放出ホルモン
 ③ 性腺刺激ホルモン放出ホルモン

スライドでは「視床下部」が太字、「**ギナドトロピン放出ホルモン(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)**」が赤字。図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。



スライド34の図

□□□ No.21の②の刺激によって下垂体前葉から放出され
22 る ① (FSH)と ② (LH)の2種類ホルモ
★★★ ンを、まとめて ③ (④)という。

- らんぼう
① 卵巣刺激ホルモン
おうたい
② 黄体形成ホルモン
③ 性腺刺激ホルモン
④ ギナドトロピン

卵巣の成熟は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.21の図の中段で、下垂体前葉から出る2つのホルモンと、その間に書かれた「**ギナドトロピン(性腺刺激ホルモン)**」を確認しよう。

□□□ FSHは ① を刺激して、女性ホルモンである
23 ② を分泌させる。男性では、FSHは ③ を促
★★ 進する。

重要

- らんぼう
① 卵巣
② エストロゲン
③ 精子形成

まとめ:FSHは卵巣を刺激して、エストロゲンを分泌させる(スライドでは「FSH」が赤字・太字・下線、「**卵巣を刺激**」が太字)。No.21の図の左側(FSH→卵巣→エストロゲン(女性ホルモン))で確認しよう。

□□□ 女性では、LHは ① と ② の分泌を促進す
24 る。また、LH濃度の ③ によって排卵が誘発され
★ る。これを ④ という。

重要

- ① エストロゲン
② プロゲステロン
③ 急上昇
④ LHサージ

まとめ:LH濃度の**急上昇によって、排卵が誘発**される(スライドでは太字・下線)=**LHサージ**(赤字・太字)。排卵後、卵巣はLHの影響を受けて**黄体**となり、**黄体**から**黄体ホルモン(プロゲステロン)**が産生される。男性では、LHはテストステロンの分泌を促進する。No.21の図の右側で、LH→**黄体**→**プロゲステロン**の流れを確認しよう。

□□□ 女性ホルモンである ① は、女性の ② を促
25 す。
★

- ① エストロゲン
にじせいちょう
② 二次性徴

スライド35に示された女性の**二次性徴**:**乳房の発達・腋毛と陰毛の発達・皮下脂肪の蓄積(とくに殿部と乳房)・骨盤の開大と発育・月経周期の発達・女性生殖器官の増大(卵管・子宮・膣など)**。

□□□ No.25の①には、No.25の②を促すほかに、
26 ① を低く維持する作用や、② を促進し
★★ ③ を抑制する作用がある。

- ① 血中コレステロール
② カルシウム摂取
はこつさいぼう
③ 破骨細胞

まとめ:**血中コレステロールを低く維持する作用・カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する作用**(スライドでは青字・太字・下線)。

□□□ 排卵は、月経周期の () 頃に起こる。
 31 月経周期は個人差が大きい、排卵から次の月経が
 ★★★ 始まるまでの期間 (No.30の⑥) は と一定している。

- ① 中間点
 ② 14日目
 ③ 14～15日

まとめ: 排卵は月経周期の中間点 (14日目) 頃に起こる (スライドでは太字)。排卵から次の月経が始まるまでの期間 (分泌期) は14～15日と一定している (スライドでは青字・太字)。No.30の図の点線 (排卵) で確認しよう。

□□□ 月経時には、剥離した組織や出血 () が
 32 として膣から体外に排出される。
 ★★

- ① 50～150ml
 ② 月経血

血液量は体重の1/13なので、40kgの女性だと3L。
 150mlの月経血は、その5%にあたる。

□□□ No.30の④の時期には、 に刺激された卵胞
 33 から、より多くの が分泌される。それが刺激と
 ★★★ なって子宮内膜が され、内膜への が
 増加する。すなわち、子宮内膜に が始まる。

- ① FSH (卵胞刺激ホルモン)
 ② エストロゲン
 ③ 修復
 ④ 血液供給
 ⑤ 受精卵が着床する準備

まとめ: 子宮内膜が修復され、内膜への血液供給が増加する (スライドでは太字) = 子宮内膜に受精卵が着床する準備。スライドのグラフでは、エストロゲンは排卵直前にピークになる。No.30の図の左下 (FSH・LH) と右下 (エストロゲン・プロゲステロン) のグラフで確認しよう。

□□□ No.30の④の時期の最後に、 の血中濃度が
 34 し、排卵が起こる。
 ★

- ① LH (黄体形成ホルモン)
 ② 突然上昇

まとめ: LH (黄体形成ホルモン) の血中濃度が突然上昇し、排卵が起こる。これがLHサージ (No.24)。No.30の図の左下のグラフで、排卵の時期に急に高くなる山を確認しよう。

□□□ 排卵が起こると、 が上昇し、頸管粘液の
 35 が低下して、 ようになる。
 ★★

- ① 基礎体温
 ② 粘稠性
 ③ 水分を多く含む

まとめ: 基礎体温が上昇する。頸管粘液の粘稠性が低下して、水分を多く含むようになる (スライドでは太字)。※スライドでは「粘調性」と書かれているが、正しい漢字は「粘稠性」(ねばりけのこと)。

- No.30の⑥の時期には、排卵後に形成される
 36 ① から ② が分泌される。これによって子宮
 ★★★ 内膜の血流がさらに増加して ③ になり、
 ④ から粘液が大量に分泌される。

- ① おうたい 黄体
 ② プロゲステロン
 ③ ふしゅじょう 浮腫状
 ④ しきゅうないまくせん 子宮内膜腺

まとめ: 血流がさらに増加して浮腫状になる→子宮内膜腺から粘液が大量に分泌される(スライドでは「粘液が大量に分泌」が太字)。スライドのグラフでは、プロゲステロンは分泌期にピークになる。No.30の図の右上で、子宮内膜腺の位置を確認しよう。

- No.36の④から粘液が大量に分泌されると、子宮腔
 37 内に ① が分泌されるとともに、卵管に向かう
 ★★ ② が子宮内を ③ なる。

- ① 栄養素
 ② 精子
 ③ 通過しやすく

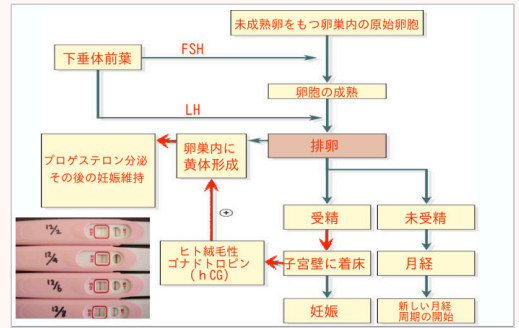
まとめ: 子宮腔内に栄養素が分泌される・卵管に向かう精子が子宮内を通過しやすくなる(スライドでは「栄養素が分泌」「精子が子宮内を通過しやすく」が太字)。

妊娠後のホルモン

- 受精が成立すると、胎盤の一部である ① から、
 38 黄体形成ホルモン(LH)と似た ② (③) の
 ★ 産生が始まる。

- ① じゅうもう 絨毛
 ② じゅうもう ヒト絨毛性ゴナドトロピン
 ③ hCG

図で、「子宮壁に着床」から出た赤い矢印がヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)を通して、「卵巣内に黄体形成」に向かっていることを確認しよう。



スライド38の図

- No.38の③は ① し、さらに黄体を刺激して、妊
 39 娠初期(②)に ③ と ④ を産生させ
 ★★ て、妊娠を継続させる。

- ① 黄体の変性を抑制
 ② 3ヶ月
 ③ プロゲステロン
 ④ エストロゲン

まとめ: 黄体の変性を抑制し、さらに黄体を刺激する(スライドでは「黄体の変性を抑制」が青字)。受精しなかった場合は、No.38の図の「未受精→月経→新しい月経周期の開始」の流れになる。

□□□ ① は、② のNo.38の③を検出している。
 40 ③ で陽性反応が出る。
 ★★
 重要

- ① 妊娠反応
 ② 尿中
 ③ 妊娠2～3週

まとめ: 妊娠反応は尿中のhCGを検出している(スライドでは太字・下線。「妊娠反応」は赤字)。「妊娠2～3週」も太字。※一般的な教科書(最終月経から数える妊娠週数)では妊娠4～5週頃とされるが、試験はスライドどおり。

□□□ プロゲステロンは、通常時は ① から分泌され
 41 (別名 ②)、その分泌は ③ (④) の刺
 ★★ 激によって起こる。

- ① ^{おうたい}黄体
 ② 黄体ホルモン
 ③ 黄体形成ホルモン
 ④ LH

スライド39は、プロゲステロンのまとめ(【通常時】と【妊娠中】)。黄体・黄体ホルモン・黄体形成ホルモンを混同しないように(黄体形成ホルモンは下垂体前葉から分泌され、黄体を形成させる。No.7)。

□□□ プロゲステロンは、妊娠初期には ① に刺激され
 42 た ② から分泌されるが、妊娠が進むと ③
 ★★★ から分泌される。妊娠 ④ 後からは、プロゲステ
 ロンやエストロゲンは ③ から分泌されるので、
 卵巣は ⑤ に入る。

- ① hCG
 ② ^{おうたい}黄体
 ③ ^{たいばん}胎盤
 ④ 3ヶ月
 ⑤ 休眠状態

まとめ: 妊娠初期はhCGに刺激された黄体から、妊娠が進むと胎盤から分泌(スライド39では赤字)。妊娠3ヶ月後からプロゲステロンやエストロゲンは胎盤から分泌されるので、卵巣は休眠状態に入る(スライド42では青字・太字)。

□□□ 妊娠中のプロゲステロンは、 ① の収縮を抑制
 43 し、 ② を準備する。
 ★

- ① ^{しきゅうきん}子宮筋
 ② 母乳分泌

まとめ: 子宮筋の収縮を抑制する・母乳分泌を準備する。No.38の図にも「プロゲステロン分泌 その後の妊娠維持」とある。

受精

□□□ 卵母細胞は排卵後 ① 生存する(②)。精
 44 子は女性生殖器官内で ③ 受精能力を維持する(★★★
 ④)。

- ① 12～24時間
 ② 1日以内
 ③ 12～48時間
 ④ 2日以内

どちらも時間が限られているので、受精できる期間も限られる(次の問題)。※時間は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□ No.44の①～④から、受精を起こすためには、性交を
 45 排卵前 ① から排卵後 ② 以内に行う必要
 ★★ がある。

① 2日

② 24時間

まとめ: 排卵前2日から排卵後24時間以内 (スライドでは青字・太字)。卵母細胞は1日以内しか生存せず、精子は2日以内しか受精能力を維持しないことから考えよう。

□□□ 精子は、卵母細胞を探し出す「 ① 」のような
 46 ② によって誘導される。
 ★

① 自動誘導装置

② 化学物質

まとめ: 「自動誘導装置」のような化学物質 (スライドでは「自動誘導装置」が太字)。

□□□ 射精された何百万もの精子のうち、卵母細胞の近く
 47 に達するのは ① の精子 (②) だけで、他は
 ★★ ③ によって破壊される。

① 数百～数千

② 0.01～0.1%

③ 酸性

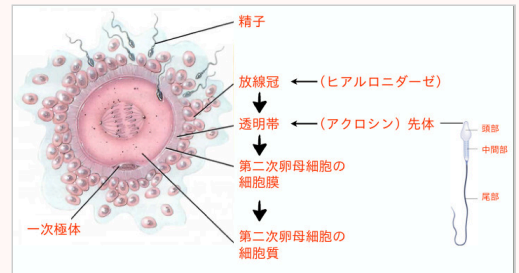
スライドでは「0.01～0.1%」が青字・太字・下線、「酸性によって破壊」が太字。

□□□ 卵母細胞に到達すると、精子細胞表面の ① が、
 48 卵母細胞の ② を破壊する。
 ★★

① ヒアルロニダーゼ

② 放線冠

図で、放線冠(ヒアルロニダーゼ)→透明帯(アクロシン)→第二次卵母細胞の細胞膜→細胞質の順に、精子が進んでいくことを確認しよう。



スライド41の図

□□□ 続いて、精子の先端にある ① で ② が生じ、
 49 ③ という蛋白分解酵素によって、精子が
 ★★ ④ を貫通しやすくなる。

① 先体

② 先体反応

③ アクロシン

④ 透明帯

No.48の図の右端の精子で、頭部の先端にある先体を確認しよう。酵素と、それが働く層の組み合わせ(ヒアルロニダーゼ→放線冠、アクロシン→透明帯)に注意。

□□□ 最終的には ① の精子が卵母細胞と ② を
 50 おこし、精子の内容物が卵母細胞の細胞質内に引き
 ★ 込まれる。

① 1個

② 細胞融合

まとめ: 1個の精子が卵母細胞と細胞融合をおこす (スライドでは「細胞融合」が太字)。

- 精子が侵入すると、卵母細胞の核は ① を完了
 51 させ、② と ③ を形成する。また、それ以上
 ★ の精子が侵入してこないような反応が起きる。

① 減数第2分裂

- ② 卵子
にじきょくたい
 ③ 二次極体

スライドでは「減数第2分裂を完了」が太字。No.8と同じ内容(スライド27では「第二極体」と書かれている)。

受精から着床・胎盤形成

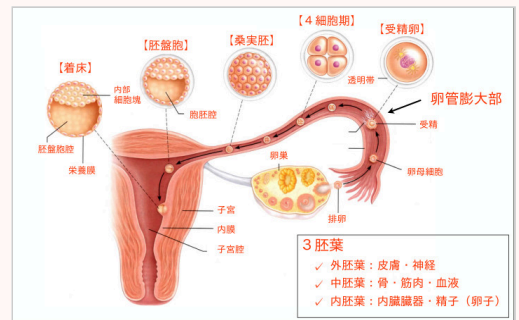
- 受精は ① (②) で起こる。受精卵は
 52 ③ を繰り返しながら、子宮腔に向かって移動す
 ★★ る。

重要

① 卵管の入り口付近

- らんかんほうだいぶ
 ② 卵管膨大部
らんかつ
 ③ 卵割

まとめ: 受精は卵管の入り口付近(卵管膨大部)で起こる(スライドでは太字・下線。「卵管膨大部」は赤字)。図の右上の卵管膨大部から左の【着床】まで、胚が変化しながら移動していくようすを確認しよう。



スライド42の図

- 排卵後 ① には、胚は ② の細胞からなるボ
 53 ール状の ③ になる。
 ★★

① 3日目

- ② 16個
そうじつはい
 ③ 桑実胚

まとめ: 16個の細胞からなるボール状の桑実胚(スライドでは「排卵後3日目」「16個」が太字)。No.52の図の【桑実胚】を確認しよう。※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

- 排卵後 ① に、細胞は ② 近くになり、内部を
 54 くりぬいたボール状の ③ になる。
 ★★

① 4日目

- ② 約100個
はいばんほう
 ③ 胚盤胞

まとめ: 約100個近くの細胞からなる胚盤胞(スライドでは「排卵後4日目」「約100個」が太字)。胚盤胞はhCGを分泌し、卵巣の黄体を刺激してプロゲステロンを分泌し続けさせる(No.38)。No.52の図の【胚盤胞】を確認しよう。

□□□ No.54の③は、中に液体が入った ① と、細胞の
55 集団である ② からなる。
★★

① 栄養膜
えいようまく
ないぶさいぼうかい
② 内部細胞塊

No.52の図の【胚盤胞】で、内部細胞塊と栄養膜の位置を確認しよう。

□□□ No.55の②の細胞は3つの胚葉に分化する。皮膚・
56 神経になる ①、骨・筋肉・血液になる ②、
★★★ 内臓臓器・精子・卵子になる ③ である。

① 外胚葉
がいはいよう
ちゅうはいよう
② 中胚葉
ちゅうはいよう
ないはいよう
③ 内胚葉

まとめ：外胚葉：皮膚・神経／中胚葉：骨・筋肉・血液／内胚葉：内臓臓器・精子・卵子。No.52の図の右下の枠(3胚葉)にもまとめられている。No.58の図には、3つの胚葉の位置が示されている。

□□□ 排卵後 ① までに、No.54の③は子宮内膜に付
57 着して、子宮粘膜を侵食して侵入する。これを
★ ② という。

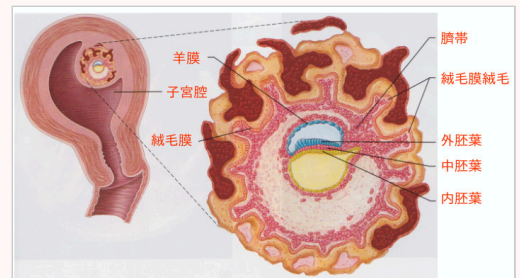
① 7日目
ちやくしゅう
② 着床

まとめ：着床(排卵後7日目までに)(スライドでは「排卵後7日目」が太字)。No.52の図の左端が【着床】。※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□ No.57の②の後、No.54の③は ① という多数
58 の ② を出し、③ と結合して ④ を形成
★★ する。

じゅうもうまくじゅうもう
① 絨毛膜絨毛
② 突起
③ 子宮の組織
たいばん
④ 胎盤

まとめ：子宮の組織と結合して、胎盤を形成する(スライドでは「突起」が太字、「子宮の組織と結合」が下線)。図の右側の拡大図で、絨毛膜絨毛を確認しよう。



スライド43の図

□□□ No.58の④は、胚に ① と ② を供給し、
59 ③ を除去する。また、妊娠期間中に内分泌器官
★ として ④ や ⑤ を分泌する。

- ① 酸素
- ② 栄養素
- ③ 老廃物
- ④ エストロゲン
- ⑤ プロゲステロン

まとめ: 酸素と栄養素を供給し、老廃物を除去する。エストロゲンやプロゲステロンを分泌(スライドでは青字・太字・下線)。妊娠が進むと、これらのホルモンは卵巣ではなく胎盤から分泌される(No.42)。

□□□ No.58の④が形成されると、 ① に囲まれた胚は
60 ② に取り囲まれる。そして、血管を含む ③
★ によって、No.58の④に付着する。

- ① 羊膜 ようまく
- ② 羊水 ようすい
- ③ 臍帯 さいたい

まとめ: 臍帯(胎盤に付着する)(スライドでは「胎盤に付着」が太字)。No.58の図で、羊膜と臍帯の位置を確認しよう。

□□□ 妊娠期間は最後の月経日より ① 続く。 ②
61 を妊娠0週0日とするので、受精の瞬間は妊娠
★★ ③ 頃になる。

重要

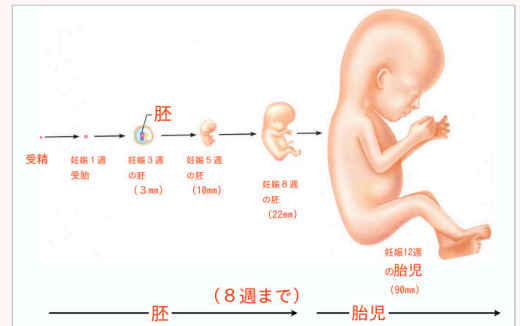
- ① 280日間
- ② 最終月経開始日
- ③ 第2週

まとめ: 最後の月経日より280日間(スライドでは赤字・太字)。「最終月経開始日を妊娠0週0日」「受精の瞬間は妊娠第2週頃」は太字。

□□□ 受精から ① ままで ② と呼び、 ③ から
62 出生までを ④ と呼ぶ。出生後、 ④ は
★★ ⑤ となる。

- ① 8週間目
- ② 胚 はい
- ③ 9週 たいじ
- ④ 胎児 たいじ
- ⑤ 乳児 にゅうじ

図の下矢印(胚(8週まで)→胎児)で確認しよう。



スライド44の図

子宮内膜症・子宮筋腫

- 子宮内膜が ① で増殖する病気を ② という。子宮の外にあるが子宮内膜としての性質があり、
 63 ★ ③ に反応して ④ に伴い発育していく。

- No.63の②の好発部位は、① ・ ② ・
 64 ③ ・ ④ などである。
 ★★

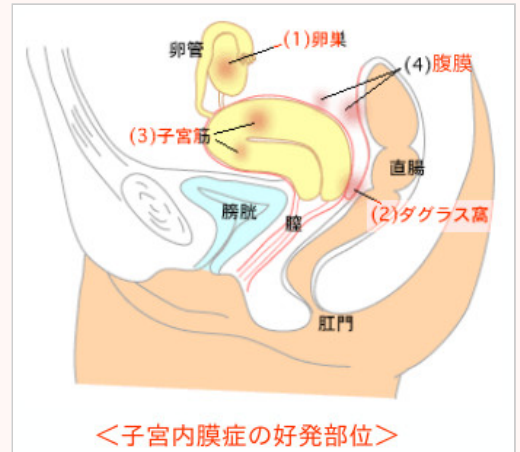
- No.63の②の症状は、① 、 ② 、 ③ 、
 65 ④ (月経の血液量が多い)、⑤ などであ
 ★★ る。⑤ の ⑥ がNo.63の②である。

- ① 子宮外
しきゅうないまくしゅう
 ② 子宮内膜症
 ③ エストロゲン
 ④ 月経周期

まとめ: 子宮内膜が子宮外で増殖する(スライドでは青字・太字)。「エストロゲンに反応」も太字。

- ① 卵巣
らんそう
 ② ダグラス窩
か
 ③ 子宮筋
しきゅうきん
 ④ 腹膜
ふくまく

図で、(1)～(4)の位置を確認しよう。ダグラス窩は、図では子宮と直腸の間のくぼみ。



<子宮内膜症の好発部位>

スライド46の図

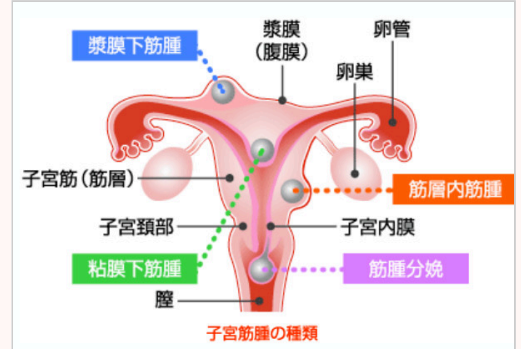
- ① 月経痛
 ② 生理痛以外の腹痛
 ③ 性交痛
 ④ 過多月経
かたげつけい
 ⑤ 不妊症
 ⑥ 20%

まとめ: 月経痛・生理痛以外の腹痛・性交痛・過多月経(月経の血液量が多い)・不妊症。スライド46の左側にも、5つの症状が並んでいる。

- 子宮の良性腫瘍で、①の塊であるものを
 66 ②という。症状は筋腫の大きさやできる場所に
 ★★ よって異なり、無症状のものから③・④・
⑤までである。

- ① 平滑筋
 ② 子宮筋腫
 ③ 月経過多
 ④ 生理痛
 ⑤ 不妊症

まとめ: 子宮筋腫(平滑筋の塊)。図は、筋腫ができる場所の違い(漿膜下・筋層内・粘膜下など)を示している。



スライド47の図

- No.66の②は生殖可能期間に成長するが、①
 67 しているので、②によって増大する。また、
 ★ ③は縮小する傾向があり、④はしない。
 重要

- ① ホルモンに依存
 ② 妊娠
 ③ 閉経後
 ④ 悪性化

まとめ: ホルモンに依存しているので、妊娠によって増大する(スライドでは太字・下線。「妊娠によって増大」は赤字)。閉経後は縮小する傾向がある(太字・下線)。悪性化はしない(下線)。

子宮頸癌・子宮体癌

- 子宮頸癌は①に発生する癌で、②(
 68 ③: ④)の感染が原因である。
 ★
 重要

- ① 子宮頸部
 ② ヒト乳頭腫ウイルス
 ③ パピローマウイルス
 ④ HPV

まとめ: ヒト乳頭腫ウイルス(パピローマウイルス:HPV)の感染が原因(「HPV」は赤字・太字)。子宮癌には、頸部にできる子宮頸癌と体部にできる子宮体癌(No.73)があり、性質が全く異なる。

□□□ 子宮頸癌は、の多い女性や、の性行為が高リスクで、まで増加する。

★★

① 妊娠・出産回数

② 不特定多数

③ 20歳代後半から40歳前後

まとめ: 妊娠・出産回数の多い女性・不特定多数の性行為が高リスク。スライド49では、HPV感染の起こりやすい状況として、性交渉の相手が多い・妊娠・出産回数が多・性交渉開始年齢が低いあげられている(ただし「子宮頸癌の患者=性交渉活発ではない」とも書かれている)。

□□□ 子宮頸癌は、初期はで、進行するとがみられる。早期発見での5年生存率はである。

★★

① 無症状

② 不正出血

③ 70～90%

子宮体癌の早期発見での5年生存率も70～90%(スライド51)。

□□□ 子宮頸癌はで予防可能である。はが成立する前に接種しないと有効性がないので、なるべく性交渉を開始する前()に接種することで有効性が高くなる。

★

① ワクチン

② HPV感染

③ 10代

まとめ: 子宮頸癌はワクチンで予防可能(スライド48では青字)。HPV感染が成立する前に接種しないと有効性がなから、性交渉を開始する前(10代)に接種する。ワクチンには、サーバリックス、ガーダシル、シルガード9がある。

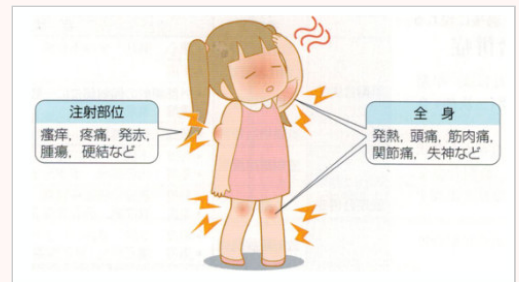
□□□ No.71の①では、全国で接種した延べ663万5千人のうち956人にが起きている()。

★★

① 副反応

② 0.01%

発熱、注射部位の痛み・腫れ、失神が多いが、まれに「四肢の運動能力低下」「歩行不能」などで未回復の重症例もある(100万～400万回接種に1回)。2013年から厚労省は積極的勧奨を中止していたが、2021年に入ってから再開した。



スライド50の図

□□□ 子宮体癌は [①] に発生する癌で、[②] から発生する。[③] ([④]) が発症に関与する。
73 ★

- しきゅうたいぶ
① 子宮体部
② 子宮内膜
③ 女性ホルモン
④ エストロゲン

まとめ: 子宮体部(子宮内膜から発生)。子宮頸癌(No.68)とは、発生する部位も原因も違う。

□□□ 子宮体癌の発生は、[①] ([②]) に対して、
74 [③] ([④]) が [⑤] ことが原因と考えられている。
★★★ 重要

- ① 黄体ホルモン
② プロゲステロン
③ 女性ホルモン
④ エストロゲン
⑤ 相対的に多くなる

まとめ: 黄体ホルモン(プロゲステロン)に対して、女性ホルモン(エストロゲン)が相対的に多くなること(スライドに★で明記)。

□□□ 子宮体癌は [①] ([②]) に多く、[③] の不正出血で気づく。子宮頸癌に比べて [④] が低い
75 ★★ ので、[⑤] も低い。

- ① 中高年
② 50～60歳代
③ 閉経後
④ 検診率
⑤ 早期発見率

まとめ: 検診率が低いので、早期発見率も低い(スライドでは「子宮頸癌に比べて検診率が低い」が太字)。早期発見での5年生存率は70～90%。

□□□ 子宮体癌の危険因子には、[①] (出産歴がない)、
76 [②] (初経が早い)、[③] ([④] 以上)
★★★ のほか、肥満・糖尿病・高血圧などがある。

- みさん
① 未産
そうきしよけい
② 早期初経
ばんきへいけい
③ 晩期閉経
④ 53才

まとめ: 出産歴がない(未産)、初経が早く閉経が遅い(早期初経・晩期閉経:53才以上)(スライド51では「初経が早く閉経が遅い」が太字・下線)。ほかに、閉経後の高エストロゲン・乳がんの既往も危険因子。

□□□ 肥満の人は閉経後でも、[①] から分泌されない
77 はずのエストロゲンが [②] から分泌される。そのため、肥満は子宮体癌の危険因子となる。
★★

- ① 卵巣
② 脂肪細胞

まとめ: 肥満の人は閉経後でも、卵巣から分泌されないはずのエストロゲンが脂肪細胞から分泌されるから。子宮体癌は、エストロゲンが相対的に多くなることが原因(No.74)。

□□□ ① (②) の長期服用も、子宮体癌の危険
 78 因子である。① は ③ を持ち、乳癌の治療
 ★★ 薬として使用されている。

- ① **タモキシフェン**
 ② **ノルパデックス**
 ③ **抗エストロゲン作用**

まとめ: **抗エストロゲン作用を持ち、乳癌の治療薬として使用されている。** 乳癌の治療薬が、子宮体癌の危険因子になることに注意。

乳がん・卵巣癌

□□□ 日本では、① の女性が乳がん^{りかん}に罹患する。毎年
 79 3万5千人が罹患し、② が亡くなる。
 ★★★

- ① **25～30人に1人**
 ② **1万人近く**

アメリカでは8人に1人。乳がんは、早期発見で5年生存率90%以上。※数値は統計の年によって異なるが、試験はスライドどおり。②はスライド53の数値(スライド54の「2015年には1万3千人を超え」とは別)。

□□□ 乳がんは30代後半から増加し、① と ② に
 80 ピークがある。③ ・ ④ 、エストロゲン補充
 ★★ 法、出産経験が無い、授乳経験が無い、高齢出産などが高リスクである。

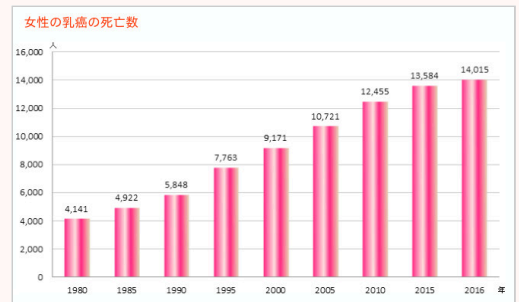
- ① **40代後半**
 ② **60代前半**
 ③ **早い初経**
 ④ **遅い閉経**

スライドでは「30台後半」「**40台後半と60台前半**」と書かれている(「台」は「代」の意味)。「**早い初経**」「**遅い閉経**」は太字・下線。子宮体癌の危険因子(No.76)とも共通している。

□□□ 日本では乳癌が増加しており、乳癌で亡くなる女性
 81 は2015年には1万3千人を超え、① と比べると
 ★★ ② になっている。

- ① **35年前**
 ② **3倍以上**

スライドでは「**35年前と比べると3倍以上**」が太字・下線。グラフで、乳癌による死亡数の増え方を確認しよう。



スライド54のグラフ

□□□ ① または ② 遺伝子に欠陥がある ③
82 の乳癌を ④ といい、乳がん全体の ⑤ を占
★★ める。

- ① BRCA1
- ② BRCA2
- ③ 遺伝性
いでんせい に ゆうがんらんそうがんしょうこうぐん
- ④ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群
- ⑤ ～5%

異常なBRCA1やBRCA2遺伝子を持った人は、乳癌が若い時から発症しやすくなる(55～85%に乳がんができる。家族性乳がん)。

□□□ No.82の④は、① で発症し、② である。ま
83 た、③ になるリスクも高い。
★

- ① 若年
じゃくねん
- ② 両側性
りょうそくせい
- ③ 卵巣がん

まとめ: 遺伝性・若年で発症・両側性・卵巣がんになるリスクも高い。

□□□ ① は、症状が出るのが ② 、③ される
84 ことが多い。通常は ④ や ⑤ が無い。婦人
★★ 科悪性腫瘍の中で ⑥ 。

- ① 卵巣癌
- ② 遅く
- ③ 進行して診断
- ④ 月経異常
- ⑤ 不正出血
- ⑥ 最も死亡率が高い

まとめ: 症状が出るのが遅く、進行して診断されることが多い。通常は月経異常や不正出血が無い(「無い」に下線)。症状は、お腹が張る、腹痛、頻尿、体重減少など。超音波検査により、初期の癌が見つかりやすくなった。